ETAT DES LIEUX DE LA MISE EN ŒUVRE DES SOINS MATERNELS KANGOUROU DANS LE SERVICE DE PÉDIATRIE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BOGODOGO (CHU-B) DE JANVIER À AOÛT 2022.

OUEDRAOGO Paul[1], TIENDREBEOGO Larissa[2], BILGO Aimé[3], OUEDRAOGO/YUGBARE Solange[2,3]

1. Université Saint Thomas d'Aquin
2. Université Joseph Ki Zerbo
3. Centre Hospitalier Universitaire de Bogodogo

PLAN

- INTRODUCTION
- OBJECTIF
- MATÉRIEL ET MÉTHODE(S)
- RÉSULTATS
- CONCLUSION

INTRODUCTION

- Soins maternels kangourou (SMK) = Méthode mère kangourou(MMK) = contact peau ≠ peau , mère - Nné FPN + Allaitement exclusif

- Partie intégrante de PEC des Nnés FPN au CHU-B (Janvier 2022)

- **But** : Améliorer la prise en charge des Nnés FPN

OBJECTIF

- **Général**

Faire l'état des lieux de la mise en œuvre des Soins Maternels Kangourou dans le service de pédiatrie du CHU-B de janvier à Août 2022.

OBJECTIF

❑Spécifiques

1. Déterminer la fréquence des nouveau-nés mis sous SMK
2. Décrire le profil sociodémographique des nouveau-nés mis sous SMK
3. Enumérer les aspects cliniques et paracliniques des nouveau-nés mis sous SMK
4. Apprécier l'évolution des nouveau-nés avant et pendant SMK
5. Evaluer le coût direct de la PEC des nouveau-nés mis sous SMK.

MATÉRIEL ET MÉTHODE(S)

- **Cadre d'étude** : service de pédiatrie du CHU-B
- **Type et période d'étude** : étude descriptive à collecte de données rétrospective du 1er Janvier au 31 Août 2022
- **Population d'étude** : nouveau-nés de FPN admis en soins kangourou durant la période d'étude

MATÉRIEL ET MÉTHODE(S)

❑Critères d'inclusion

➢ Tous les nouveau-né admis en SMK durant la période d'étude et dont le dossier était exploitable

❑ Critères de non inclusion

➢ Tous les nouveau-né de FPN n'ayant pas bénéficié des SMK ou ayant un dossier non exploitable ou perdu

MATÉRIEL ET MÉTHODE(S)

- **Support et sources de collectes de données :**
  - Fiche de collecte
  - Dossiers médicaux
  - Registres d'hospitalisation / registres de suivi
- **Saisie et analyse des données:**
  - Word/Excel 2016
  - Logiciel Epi info 7.2.5.0

RESULTATS (1/10)

❑ Données épidémiologiques

➢ **Fréquence** = **51,49%** (N = 121)

➢ **Sex-ratio** = **0,78**
- Féminin = **56,19%**
- Masculin = **43,81%**

RESULTATS (2/10)

❑ Données épidémiologiques

- **Age moyen des mères** = **27,4 ans** [15- 44a]

  = **44,44%** [20-29] +++

- **Niveau d'instruction des mères** = **63,63%** Non scolarisées
- **Profession des mères** = **70,59%** FAF
- **Résidence** = **71,57%** Urbaine

RESULTATS (3/10)

❑ Aspects cliniques

➢ **Délai d'admission**

- ≤ 24 premières heures = **95,87%**
- > 24 première heures = **4,13%**

➢ **Motif d'admission**

- Prématurité = **75,2%**
- Détresse respiratoire = **22,31%**

RESULTATS (4/10)

❑ Aspects cliniques

- **Parité**
  - Primipare = **28,81%**
  - Grande multipare = **7,63%**
- **Nombre de consultation prénatales**
  - < 04 CPN = **63,03%**
  - ≥ 04 CPN = **36,97%**

RESULTATS (5/10)

❑ Aspects cliniques

➢ **Mode d'accouchement**

- Voie basse = **70,25%**
- Césarienne = **29,75%**

➢ **Poids de naissance moyen** = **1403,80 g**

RESULTATS (6/10)

❑ Aspects para cliniques

- **Hémogramme :** Anémie = **59,63%**
- **Biochimie**
  - Hypocalcémie = **51,76%**
  - Hypoglycémie = **30%**

RESULTATS (7/10)

❑ Evolution des nouveau nés avant et pendant SMK

➢ **Délai moyen de mise sous SMK** = **12,54 jours [3 - 51j]**

= **36,36% [7 - 13] +++**

➢ **Gain pondéral moyen**

Pendant SMK = **25,81 g/jour**

#

Avant SMK = **11,25 g/jour**

RESULTATS (8/10)

❑ Evolution du poids du nouveau-né avant et pendant SMK

➢ **Perte pondéral moyenne**

- Pendant SMK = **12,14 g/jours**

#

- Avant SMK = **15,28 g/jours**

RESULTATS (9/10)

❑ Evolution du poids du nouveau-né avant et pendant SMK

➢ **Les complications**

Avant SMK = **Anémie : 71,90%, Hypothermie: 28,1%**

Pdt SMK = **Anémie : 53,71%, Ictère : 32,23%**

➢ **Durée d'hospitalisation moyenne en SMK = 09,82 jours [2-29 j]**

RESULTATS (10/10)

❑ Modalités évolutives à la sortie

- **Sortie pour guérison** = **97,52%**
- **Sortie contre avis médical** = **1,65%**
- **Décès** = **0,83%**
- **Abandon SMK** = **4,13%**
- **Coût direct moyen d'hospitalisation** = **183587 f CFA** [41025 - 558169 f]

Conclusion

- SMK instaurés au BF pour ↘ mortalité néonatale
- Résultats de MEO des SMK au CHU-B satisfaisants
- Taux de décès relativement bas
- MMK = bonne alternative aux soins conventionnels
- Mener une étude comparative SMK # soins conventionnels / analytique sur le suivi en ambulatoire

Merci pour votre attention